

1 例左侧鼻翼缺损再造术的护理

章筱芬

(181医院五官科 桂林 541002)

一、病例介绍

患者,男,32岁,工人。1994年8月18日8时许被人用刀砍伤左鼻翼,当时感到局部出血,触摸发现左鼻翼缺失,即到当地卫生院包扎,并给予抗炎止血治疗(药名不详)。伤后两天到我院就诊,门诊检查发现左鼻翼全缺损,可直视鼻腔,无活动性出血,双鼻腔未见分泌物及新生物,咽喉及耳部未见异常。以“左鼻翼缺损”收入我科。患者伤后无发热,无恶心呕吐,生命体征正常,心、肺、腹部无异常。入院第四天在局部麻醉下进行移植部分右耳廓再造鼻翼成形术。手术过程顺利,术后经过精心护理和治疗,右耳廓切口愈合。术后七天取出左鼻腔纱条,鼻翼未见塌陷,第九天拆线。住院36天,左鼻翼移植成活,成形自然,痊愈出院。

二、术前护理

术前向患者说明手术过程和术后反应,要求患

者术中切勿紧张,不要煽动鼻翼和打喷嚏,若将要发生可作深呼吸制止。术前当晚用香皂水清洁面部、剃胡须,剪鼻毛,术晨再次清洗,并用外用盐水冲洗鼻腔,无菌纱布遮盖伤口。鲁米那钠0.1g术前30分钟肌注。

三、术后护理

仔细观察左鼻手术局部血运及出血情况。术后鼻腔用碘仿纱条填塞一周,起止血、支撑、固定作用。术后右耳廓切口换药每日一次,左鼻翼换药每日二次,无菌纱布包扎一周。术后不需特殊体位。

为改善左鼻翼移植物的血液供应及神经功能恢复,给予AFP、烟酸和维生素P等神经营养及扩张血管药物。并采用红外线等局部理疗手段,以促其成活。防止感冒,注意保暖,嘱患者勿打喷嚏,勿用力擤鼻或作剧烈运动。

饮食与药物相互作用的分析与护理

邢小燕

(武警湖北总队医院三内科 武汉 430061)

在临床药物治疗中,一些药物常常被要求在饭前或饭后口服,而另一些药物则要求在清晨或睡前给予。之所以这样要求,除考虑到药物不良反应(胃肠道反应等)外,还有一个非常重要的因素就是食物对药效的影响。饮食前后给予口服药主要是影响药物在胃肠的吸收,所以,在用药时,有必要考虑食物在药物的相互作用及食物对消化道生理状态的影响。

一、胃排空速率对药物吸收的影响

药物从胃经幽门到达小肠上部的速度称做胃排

空率。胃排空速率能影响药物的吸收是由于胃与小肠之间的pH位不同。例如:弱碱性药物苯丙胺等的吸收主要在小肠而不是胃,因此延迟胃排空就会延迟吸收,亦延迟了药物疗效的发挥。而弱酸性药如胃蛋白酶等主要在胃内吸收,胃排空增速,药物吸收就会受到影响。不同食物的胃排空速率也不相同,排空速率与食物的物理性状和化学组成密切相关。稀的软体食物较稠的或固体食物胃排空速率快,如:碳水化合物较蛋白质快,而蛋白质较脂肪快。对混合食物,胃全部排空常常需要4—6小

时。

二、食物与药物相互作用

食物对药物的影响包括对药物的吸收、分布、代谢和排泄的动力学过程的影响,以及包括对药物药效学的直接影响。人体摄取食物其积极作用是补充机体适当的营养,提高人对药物的耐受力,从而增加药物疗效。但特殊的食物成分也可能成为干扰药物的吸收和发挥最大药效的因素。例如:食物中的氨基酸可与左旋多巴竞争吸收部位,而显著降低后者的吸收;食物中的钙、镁、铝、铁等离子可与某些抗生素形成胃肠道难以吸收的络合物,从而减少两者的吸收。另外,高蛋白的膳食对药物的影响。例如:大豆、牛肉、鸡肉、花生、牛乳等,因它们在肠内产生大量阻碍左旋多巴吸收的氨基酸,故使抗帕金森病药物左旋多巴吸收减少。高脂膳食也降低某些药物的吸收,如铁剂,由于脂肪抑胃酸分泌,使胃酸减少而影响 Fe^{3+} 变成 Fe^{2+} ,这样,不利于铁吸收。

三、药物对营养的影响

病人在长期用药的情况下,特别是老年多病的患者,许多药物可影响病人的食欲,引起口干、味觉的改变,干扰体内对营养素的合成、吸收、转运、代谢和排泄,影响营养素的利用。由于疾病带来人体活动降低,往往出现营养不足。若长期服用影响营养吸收和利用的药物,则可引起营养不良或营养缺乏症。为了防止和控制药物引起的营养不良,可采取多种措施,如限制多种药物同时使用;向病人及亲属宣传不适当用药的危害,监测病人服药期间的营养状况,及时补充适当的营养物质等。

四、酒对药物的影响

酒与药物合用可明显影响药物的作用。酒中的

主要成分为酒精,亦称乙醇,它是一种酶诱导剂。乙醇能加速或延迟某些药物吸收和代谢。大剂量酒精对药酶有抑制作用。如饮酒同时服用巴比妥类、或抗凝血药,因药酶被抑制,使药物代谢延缓,半衰期延长,容易引起药物蓄积,甚至发生蓄积中毒。服用少量酒精对药酶也起诱导作用,加重一些药物如苯巴比妥、苯妥因钠、安乃近等药物的代谢,使半衰期缩短,药效降低。乙醇能加重或延迟某些药物吸收和代谢。其他药物也可能加速或延迟乙醇的吸收和代谢。所以,护士在给病人使用能与乙醇产生相互作用的药物时,有必要询问病人是否有饮酒嗜好,或告诉病人在治疗期间需要禁酒,并说明可能发生的不良反应。争取病人配合,确保用药安全、有效,从而提高护理质量。

五、食物与药物合理应用的护理

长期临床实践中,医护人员愈来愈注意到:口服给药与饮食相关;不同时间用药引起不同的药效;药物作用的持续时间依赖于体内的消除速率和吸收速率。药理学上所说的饭前、饭后或饭间给药,取决于各种情况所需要的确切作用。长期以来,临床上通常指定饭后服药,因为这样可以方便地提醒病人不致于忘记服药。显然,这种千篇一律的服药时间是不合理的。它不利于某药物发挥疗效。一般地,对于某些局部作用的药物,如制酸剂饭前或饭后均可服用,其理由是不涉及吸收问题;有些药物如乙酰水杨酸对胃肠道有不良反应,可以在饭后服用,因为这样吸收未受到严重影响,而且食物的存在可减轻不良反应。另外脂肪存在有助于吸收的药物,须在饭间服用;而需要直接在肠道部作用的药物,只有在空腹时用药才能使药物迅速到达作用部位,如枸橼酸噻嗪等。

老年慢性阻塞性肺病合并多脏器损伤的观察与护理

王晓莉 郭力 谢景萍

(武汉总医院呼吸内科 武汉 430070)

老年慢性阻塞性肺病(COPD)病人,因病情长期反复发作,长期感染,机体抵抗力下降,容易引起以心、脑、肾为主的多脏器功能损害。而多脏

器功能损害是引起老年COPD患者死亡的主要原因,受损脏器愈多,损害程度愈重,死亡率愈高。护理工作在该病的救治过程中,占有重要地位,观